LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 8 Bệnh tay chân miệng

Biên soạn lại từ tài liệu Bệnh tay chân miệng.pdf (12 trang) · Giải thích dễ hiểu, có ví dụ, mẹo nhớ và liên hệ nha khoa · Ôn Luyện Nha Khoa

1. GIỚI THIỆU VÀ DỊCH TỄ
2. NGUYÊN NHÂN VÀ SINH BỆNH HỌC
3. LÂM SÀNG
4. CẬN LÂM SÀNG
5. CHẨN ĐOÁN
6. PHÂN ĐỘ LÂM SÀNG
7. ĐIỀU TRỊ
8. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN
9. PHÒNG BỆNH

Học xong bài này, bạn cần: nêu được tác nhân và dịch tễ bệnh tay chân miệng (TCM); trình bày đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và **phân độ**; nắm cách điều trị độ 1, 2 và nguyên tắc điều trị độ 3, 4; nêu được tiêu chuẩn xuất viện và cách phòng bệnh.

Hiểu nhanh: đa số trẻ TCM chỉ bị **loét miệng và nổi bóng nước** rồi tự khỏi. Cái nguy hiểm là một số ít (thường do **EV71**) có virus tấn công **thân não**, gây rối loạn thần kinh thực vật → **phù phổi, sốc, tử vong rất nhanh**. Vì vậy toàn bộ bài này xoay quanh một kỹ năng: **phân độ đúng để phát hiện sớm trẻ sắp chuyển nặng**.

1. GIỚI THIỆU VÀ DỊCH TỄ

- **Bệnh truyền nhiễm** lây từ người sang người, **dễ thành dịch**, do **virus đường ruột**.
- Hai tác nhân thường gặp: **Coxsackievirus A16 (CA16)** và **Enterovirus 71 (EV71)**. Các ca **biến chứng nặng thường do EV71**.
- Biểu hiện chính: **phỏng nước** ở vị trí đặc biệt: **niêm mạc miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, mông, gối**.
- Biến chứng nguy hiểm: **viêm não – màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp** → tử vong nếu không phát hiện, xử trí kịp.
- **Lây chủ yếu qua đường tiêu hóa;** nguồn lây chính: **nước bọt, phỏng nước, phân** của trẻ bệnh.
- Gặp rải rác quanh năm; ở **phía Nam** tăng cao **tháng 3–5** và **tháng 9–12**.
- Mọi lứa tuổi nhưng thường gặp **trẻ dưới 5 tuổi**, tập trung nhất **dưới 3 tuổi**. Yếu tố nguy cơ: **sinh hoạt tập thể** (nhà trẻ, mẫu giáo, khu vui chơi).
- **Thế giới:** thành dịch lưu hành ở châu Á – Thái Bình Dương từ thập niên 1990, **bùng phát lớn mỗi 3–4 năm**; tử vong ở bệnh nhân TCM liên quan EV-A71 dao động **< 0,5% đến 19%**. **CA6** gây TCM **không điển hình** ở trẻ nhỏ tại châu Âu, Đông Á, Bắc Mỹ.
- **Việt Nam:** báo cáo chính thức đầu tiên về TCM do EV71 năm **2003**; năm **2018** có **> 53.000 ca nhập viện**, 6 tử vong, EV71 chiếm ưu thế.

2. NGUYÊN NHÂN VÀ SINH BỆNH HỌC

2.1. Tác nhân

- **CA16 và EV71** thuộc họ **Picornaviridae**, chi **Enterovirus**, loài **Enterovirus A**. Một số khác (**CA6, CA10, CA12**) ít gặp hơn.

- Virion đường kính khoảng **30 nm**; 4 protein cấu trúc: **VP1, VP2, VP3** trên bề mặt, **VP4** nằm trong. Gen mã hóa **VP1** dùng nhiều nhất để phân loại phân tử; có tiềm năng phát triển **vaccine VP1 tái tổ hợp**. Chưa có bằng chứng liên quan giữa độc lực và nhóm gen EV71.

2.2. Sinh bệnh học

- Virus vào qua **đường tiêu hóa** → nhân lên ở **mô lympho hầu họng và ruột**; khoảng 10^4–10^5 virion được giải phóng trong **5–10 giờ** → bệnh **diễn tiến nhanh**.
- Virus tồn tại ở **hầu họng 1–3 tuần**, trong **phân 7–10 tuần**, thậm chí vài tháng → **có thể lây cả khi không còn triệu chứng**.
- Sau đó **nhiễm virus máu** → đến **thần kinh trung ương, cơ tim, gan, da**. Virus có thể lan vào hệ thần kinh **ngược theo dây thần kinh vận động**.
- EV71 gây **phản ứng viêm mạnh ở thần kinh trung ương**, chủ yếu ở **hạ đồi, thân não, tủy sống, nhân răng tiểu não**.
- Các chất trung gian viêm (**IL-6, IL-10, IL-13, TNF-α, IL-1β, IL-8, MCP-1**) đóng vai trò chính trong **viêm thân não** và **biến chứng hô hấp – tuần hoàn** → cơ sở dùng **IVIG** (kháng thể trung hòa virus và kháng cytokine). Corticosteroid có thể cân nhắc ở viêm não tủy, sốt kéo dài, ca nguy kịch (còn ít nghiên cứu).

> **Vì sao viêm thân não lại gây phù phổi, tăng huyết áp?** Thân não chứa **trung tâm điều khiển tim mạch và hô hấp** (hệ thần kinh thực vật). Khi bị viêm, trung tâm này "rối loạn": tim đập rất nhanh, mạch co, huyết áp tăng vọt, dịch tràn vào phổi → **phù phổi cấp**, rồi suy tim, sốc. Phổi và tim lúc đầu có thể **không bị virus tấn công trực tiếp** – "chỉ huy" mới là chỗ hỏng.

3. LÂM SÀNG

3.1. Các giai đoạn (thể cấp tính điển hình)

Giai đoạn	Thời gian	Biểu hiện
Ủ bệnh	**3–7 ngày**	Chưa có triệu chứng
Khởi phát	**1–2 ngày**	Sốt nhẹ, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy vài lần/ngày
Toàn phát	**3–10 ngày**	Loét miệng, phát ban phỏng nước, sốt, nôn; **biến chứng thường xuất hiện ngày 2–5**
Lui bệnh	**3–5 ngày** sau	Hồi phục hoàn toàn nếu không biến chứng

3.2. Triệu chứng giai đoạn toàn phát

- **Loét miệng:**
  - Xuất hiện **sau sốt 1–2 ngày**: chấm hồng ban → trong **24 giờ** thành **mụn nước 2–4 mm** → **vỡ thành vết loét** trung tâm gây **đau, chảy nước miếng, ăn uống kém**.
  - Vị trí: **phần sau khoang miệng**, nếp hầu họng, lưỡi gà, cột trước amidan, **khẩu cái mềm**; đôi khi niêm mạc má và lưỡi.
  - Vết loét có thể kéo dài **hàng tuần**.
- **Phát ban sẩn – mụn nước:**
  - Ở **lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông**; có thể ở đùi, khuỷu tay.
  - Kích thước **2–10 mm**, tròn / bầu dục, nổi cộm hoặc ẩn dưới da, trên nền hồng ban; **không đau, không loét**; tồn tại **dưới 7 ngày**, khi khô để lại **vết thâm**.
  - **CA16:** mụn nước **lớn hơn**; **EV71:** hồng ban dạng **chấm** hoặc **sẩn**.

- **Sốt nhẹ 2–4 ngày** (có thể đến 7 ngày). **EV71** hay gây **sốt cao > 39 °C** và **sốt > 3 ngày** hơn CA16.
- Nôn, tiêu chảy, có thể ho.
- **Sốt cao và nôn nhiều** → **nguy cơ biến chứng** (nghĩ EV71).

3.3. Các thể lâm sàng

- **Tối cấp:** diễn tiến rất nhanh với suy tuần hoàn, suy hô hấp, hôn mê, co giật → **tử vong trong 48 giờ**.
- **Cấp tính:** 4 giai đoạn điển hình như trên.
- **Không điển hình:** ban không rõ, **chỉ có loét miệng**, hoặc có **triệu chứng thần kinh, tim mạch, hô hấp mà không có ban, loét miệng**.

> **Liên hệ nha khoa:** bác sĩ RHM có thể là người **đầu tiên** nhìn thấy loét miệng của TCM. Gặp trẻ nhỏ **sốt + loét ở phần sau miệng (khẩu cái mềm, lưỡi gà, amidan)** → **khám lòng bàn tay, bàn chân, mông, gối** tìm phỏng nước. Nước bọt chứa nhiều virus: **hoãn điều trị răng không cấp cứu**, tuân thủ phòng chống lây nhiễm, khử khuẩn ghế máy, dụng cụ.

4. CẬN LÂM SÀNG

- **Công thức máu:** bạch cầu thường **bình thường**. **Bạch cầu > 16.000/mm³** hoặc **đường huyết > 160 mg% (8,9 mmol/L)** thường **liên quan biến chứng**.
- **CRP:** bình thường (< 10 mg/L).
- **Đường huyết, điện giải, X-quang phổi:** cho ca có biến chứng **từ độ 2b**.
- **Theo dõi biến chứng:**
  - **Khí máu** khi suy hô hấp.
  - **Troponin I, siêu âm tim** khi **nhịp tim ≥ 150 lần/phút**, nghi viêm cơ tim hoặc sốc.
  - **Dịch não tủy:** chọc dò khi có **biến chứng thần kinh** hoặc chưa loại trừ viêm màng não mủ; protein bình thường hoặc tăng, tế bào bình thường hoặc tăng (đơn nhân hoặc đa nhân ưu thế).
- **Tìm virus** (từ độ 2b hoặc cần phân biệt): bệnh phẩm **hầu họng, phỏng nước, trực tràng, dịch não tủy** → **RT-PCR** hoặc phân lập virus.
- **MRI não:** chỉ khi có điều kiện và cần phân biệt bệnh ngoại thần kinh.

5. CHẨN ĐOÁN

- **Ca lâm sàng:** dựa vào **dịch tễ** (tuổi, mùa, vùng lưu hành, nhiều trẻ mắc cùng lúc) + **lâm sàng** (sốt hoặc không, **phỏng nước điển hình** ở miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông).
- **Chẩn đoán xác định: RT-PCR** hoặc **phân lập** được virus.

5.1. Chẩn đoán phân biệt

Nhóm	Bệnh	Điểm phân biệt
Loét miệng	Viêm loét miệng **áp-tơ**	Loét **sâu, có dịch tiết, hay tái phát**; không có ban tay chân
Phát ban	Sốt phát ban	Hồng ban xen kẽ, ít sẩn, thường có **hạch sau tai**
	Dị ứng	Hồng ban đa dạng, **ngứa**, liên quan dị nguyên
	Viêm da mủ	Đỏ, đau, sưng, nóng, **có mủ**
	Thủy đậu	Phỏng nước **nhiều lứa tuổi**, **rải rác toàn thân**, đau rát; có dịch tễ

Nhóm	Bệnh	Điểm phân biệt
	Nhiễm khuẩn huyết **não mô cầu**	**Mảng xuất huyết hoại tử trung tâm**
	Sốt xuất huyết dengue	Chấm xuất huyết, bầm máu, xuất huyết niêm mạc
Thần kinh	Viêm màng não vi khuẩn, viêm não do virus khác	Dịch não tủy, tác nhân
Khác	Nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi	

Mẹo phân biệt với thủy đậu: TCM có ban ở **"đầu chi và mông"** (lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông) và loét ở **phía sau miệng**. Thủy đậu ban **khắp người, nhiều lứa tuổi tổn thương cùng lúc** (dát – sẩn – bóng nước – vảy), thường bắt đầu ở thân mình, đầu.

5.2. Biến chứng

- **Thần kinh:** viêm não, **viêm não thân não** và/hoặc tiểu não, viêm não tủy, viêm màng não vô trùng, **liệt mềm cấp** kiểu bại liệt, hội chứng sau nhiễm:
  - **Giật mình: dấu hiệu chỉ điểm sớm** biến chứng thần kinh (viêm thân não), thường do EV71.
  - **Rung giật cơ (myoclonic jerk):** từng cơn ngắn **1–2 giây**, chủ yếu tay chân, trẻ **vẫn tỉnh** (tổn thương tiểu não).
  - Ngủ gà, bứt rứt, chới với, **đi loạng choạng, run chi**, mắt nhìn ngược.
  - **Yếu liệt chi (liệt mềm cấp)** do tổn thương neuron vận động sừng trước tủy (nhẹ và hồi phục tốt hơn bại liệt); **liệt dây thần kinh sọ**.
  - **Co giật, hôn mê:** dấu hiệu nặng, thường kèm suy hô hấp, tuần hoàn.
- **Tim mạch, hô hấp** (viêm cơ tim, **phù phổi cấp**, tăng huyết áp, suy tim, trụy mạch) – tiến triển **nhanh trong 2–5 ngày** sau sốt:
  - **Mạch nhanh > 150 lần/phút**; **đổ đầy mao mạch > 3 giây**; da nổi vân tím, vã mồ hôi, chi lạnh.
  - **Giai đoạn đầu huyết áp tăng**; giai đoạn sau mạch nhanh, **huyết áp tụt, không đo được**.
  - Khó thở: thở nhanh, rút lõm ngực, **thở rít thanh quản**, thở không đều, thở nông, thở bụng, khò khè, **cơn ngừng thở**.
  - **Phù phổi cấp: sùi bọt hồng**, khó thở, tím tái, phổi nhiều ran ẩm.

Cảnh báo: "Giật mình" ở trẻ TCM **không phải là trẻ hay giật mình bình thường** khi ngủ. Đây là dấu hiệu **viêm thân não** – cần hỏi kỹ số lần giật mình trong 30 phút, quan sát lúc khám, và **phân độ lại ngay**.

6. PHÂN ĐỘ LÂM SÀNG

Độ 1

- **Chỉ có loét miệng và/hoặc tổn thương da** (phát ban tay chân miệng).

Độ 2 – có ảnh hưởng thần kinh trung ương

- **Độ 2a** (dấu hiệu độ 1 + **một trong**):
  - Bệnh sử **giật mình ít** (< 2 lần/30 phút và **không ghi nhận lúc khám**).
  - Lừ đừ, khó ngủ, quấy khóc vô cớ.
  - **Sốt > 2 ngày liên tục** hoặc ít nhất một lần khám xác định **sốt ≥ 39 °C**.
  - **Nôn ói nhiều.**

- **Độ 2b** (biến chứng thần kinh nặng):
  - **Nhóm 1** (một trong):
  - **Giật mình ghi nhận lúc khám.**
  - Bệnh sử **giật mình ≥ 2 lần/30 phút** kèm **ngủ gà** hoặc **mạch > 130 lần/phút** (khi nằm yên, không sốt).
  - **Nhóm 2** (một trong):
  - **Sốt cao ≥ 39,5 °C** (hậu môn) **không đáp ứng thuốc hạ sốt**.
  - **Thất điều:** run chi, run người, ngồi không vững, đi loạng choạng.
  - **Rung giật nhãn cầu, lé.**
  - **Yếu chi** (sức cơ < 4/5) hoặc **liệt mềm cấp**.
  - **Liệt thần kinh sọ** (nuốt sặc, thay đổi giọng nói...).
  - **Mạch > 150 lần/phút** (khi nằm yên, không sốt).
  - Sốt cao khó hạ (≥ 39 °C không đáp ứng hạ sốt tích cực) – nếu kèm dấu hiệu khác của nhóm 2 thì **xử trí như độ 3**.

Độ 3 – rối loạn thần kinh thực vật, suy tuần hoàn hô hấp (một trong)

- **Mạch > 170 lần/phút** (nằm yên, không sốt); một số trường hợp **mạch chậm** (rất nặng).
- **Vã mồ hôi**, lạnh toàn thân hoặc khu trú.
- **Huyết áp tăng** theo tuổi: **< 1 tuổi > 100 mmHg**; **1–2 tuổi > 110 mmHg**; **> 2 tuổi > 115 mmHg**.
- Thở nhanh, **thở bất thường**: cơn ngưng thở, thở bụng, thở nông, rút lõm ngực, khò khè, **thở rít thì hít vào**.
- **Rối loạn tri giác** (Glasgow < 10).
- **Tăng trương lực cơ.**

Độ 4 – tổn thương hô hấp tuần hoàn nặng (một trong)

- **Ngừng thở, thở nấc.**
- **Tím tái / SpO_2 < 92%.**
- **Phù phổi cấp.**
- **Sốc:** mạch không bắt được, huyết áp không đo được; **tụt huyết áp** (tâm thu < 70 mmHg nếu < 12 tháng, < 80 mmHg nếu > 12 tháng); **huyết áp kẹp** (hiệu áp ≤ 25 mmHg).

Độ	Tóm tắt "chìa khóa"	Nơi điều trị
1	Chỉ loét miệng / ban	**Ngoại trú**, y tế cơ sở
2a	Giật mình ít (bệnh sử), lừ đừ, sốt > 2 ngày hoặc ≥ 39 °C, nôn nhiều	Như độ 1 + phenobarbital uống, **theo dõi sát**
2b	**Giật mình lúc khám** / ≥ 2 lần/30 phút; thất điều, liệt, sốt ≥ 39,5 °C khó hạ, **mạch > 150**	**Cấp cứu / hồi sức**
3	**Mạch > 170, huyết áp tăng**, vã mồ hôi, thở bất thường, Glasgow < 10	**Hồi sức tích cực**
4	**Ngừng thở, SpO_2 < 92%, phù phổi, sốc**	**Hồi sức tích cực**

Mẹo nhớ ngưỡng mạch (trẻ nằm yên, không sốt): 130 (2b nhóm 1, kèm giật mình) → 150 (2b nhóm 2) → 170 (độ 3). Ngưỡng huyết áp độ 3: **100 – 110 – 115** cho **< 1 tuổi – 1–2 tuổi – > 2 tuổi**.

`

7. ĐIỀU TRỊ

7.1. Nguyên tắc

- **Chưa có thuốc đặc hiệu** – chỉ điều trị **hỗ trợ, triệu chứng**; **không dùng kháng sinh** khi không có bội nhiễm.
- **Theo dõi sát, phát hiện sớm, phân độ đúng**, điều trị phù hợp.
- Ca nặng: hồi sức theo **ABC**.
- Đảm bảo **dinh dưỡng**, nâng thể trạng.

7.2. Độ 1 – ngoại trú

- Dinh dưỡng đầy đủ; trẻ bú mẹ **tiếp tục bú**.
- Hạ sốt khi sốt cao: **paracetamol 10 mg/kg/lần (uống) hoặc 15 mg/kg/lần (tọa dược) mỗi 6 giờ**.
- **Vệ sinh răng miệng**; nghỉ ngơi, tránh kích thích.
- **Tái khám mỗi 1–2 ngày trong 8–10 ngày đầu**; trẻ còn sốt tái khám **mỗi ngày** đến khi **hết sốt ít nhất 48 giờ**.
- **Tái khám ngay** khi có dấu hiệu từ độ 2a: **sốt ≥ 39 °C**; thở nhanh, khó thở; **giật mình**, lừ đừ, run chi, quấy khóc, bứt rứt khó ngủ, nôn nhiều; **đi loạng choạng**; da nổi vân tím, vã mồ hôi, tay chân lạnh; co giật, hôn mê.

> **Hiểu nhanh:** vì biến chứng hay xuất hiện **ngày 2–5**, trẻ độ 1 ở nhà vẫn cần **tái khám dày** và cha mẹ phải được **dặn rõ dấu hiệu nặng** (đặc biệt **giật mình, sốt cao, nôn nhiều, đi loạng choạng**). Hướng dẫn cha mẹ là "điều trị" quan trọng nhất ở độ 1.

7.3. Độ 2a

- Điều trị như độ 1. Sốt cao không đáp ứng paracetamol: phối hợp **ibuprofen 5–10 mg/kg/lần mỗi 6–8 giờ** (xen kẽ paracetamol; tổng tối đa **40 mg/kg/ngày**); **không dùng aspirin**.
- **Phenobarbital 5–7 mg/kg/ngày, uống.**
- Theo dõi sát dấu hiệu chuyển độ.

7.4. Độ 2b – phòng cấp cứu / hồi sức

- **Nằm đầu cao 30°**; **thở oxy qua mũi 3–6 lít/phút**; hạ sốt tích cực.
- **Phenobarbital 10–20 mg/kg truyền tĩnh mạch**, lặp lại sau 8–12 giờ khi cần.
- **Immunoglobulin (IVIG):**
  - **Nhóm 2: 1 g/kg/ngày** truyền tĩnh mạch chậm 6–12 giờ, **1 liều**; liều 2 sau 24 giờ chỉ khi nặng hơn.
  - **Nhóm 1: không chỉ định** IVIG; nhưng nếu **không giảm sau 6 giờ phenobarbital** → xem xét IVIG; trẻ vẫn giật mình liên tục, bứt rứt → theo dõi sát dấu hiệu độ 3.
- Theo dõi mạch, nhiệt, huyết áp, nhịp thở, kiểu thở, tri giác, ran phổi **mỗi 1–3 giờ trong 6 giờ đầu**, sau đó mỗi 4–5 giờ; **SpO_2 và mạch liên tục**.

7.5. Độ 3 – hồi sức tích cực

- **Oxy mũi 3–6 lít/phút**; sau 30–60 phút đáp ứng kém → **đặt nội khí quản sớm**.
- **Chỉ định đặt NKQ, thở máy: độ 4**; hoặc độ 3 kèm: thở bất thường (ngưng thở, thở bụng, nông, khò khè, rít, rút lõm); **thở > 70 lần/phút**; rối loạn thần kinh thực vật nặng (**SpO_2 dao động**, da tái, vã mồ hôi, **mạch > 180**); **gồng chi, hôn mê** (Glasgow < 10 hoặc mức P của AVPU).
- **Chống phù não:** đầu cao 30°, **hạn chế dịch (1/2–3/4 nhu cầu)**, thở máy tăng thông khí tránh tăng $PaCO_2$, giảm PaO_2.

- **Phenobarbital 10–20 mg/kg TM** trong 30 phút, lặp lại sau 8–12 giờ (tối đa **40 mg/kg/ngày**).
- **IVIG 1 g/kg/ngày** × 1 liều (liều 2 sau 24 giờ nếu nặng hơn).
- **Dobutamin:** khi **suy tim, mạch > 170** và **không tăng huyết áp**; khởi đầu **5 µg/kg/phút**, tăng 1–2,5 µg/kg/phút mỗi 15 phút, tối đa **20 µg/kg/phút**.
- **Milrinone:** khi **tăng huyết áp** (tâm thu **≥ 110** nếu < 12 tháng; **≥ 115** nếu 12–< 24 tháng; **≥ 120** nếu ≥ 24 tháng): **0,4–0,75 µg/kg/phút** trong 24–72 giờ; huyết áp ổn 12–24 giờ thì giảm dần; **ngưng ngay** nếu tâm thu < 90 (< 12 tháng) hoặc < 100 mmHg (≥ 12 tháng).
- Hạ sốt tích cực; điều chỉnh nước – điện giải, toan kiềm, hạ đường huyết; theo dõi mỗi 1–2 giờ (huyết áp động mạch xâm lấn nếu có thể).

> **Vì sao chọn milrinone khi huyết áp cao, dobutamin khi không tăng huyết áp?** Ở độ 3, tim bị "chỉ huy" sai: mạch co mạnh làm **huyết áp tăng**, tim phải bơm vào hệ quá cản. **Milrinone** vừa **tăng sức co bóp vừa giãn mạch**, giảm hậu tải. Khi huyết áp **không cao** mà tim suy, cần **dobutamin** tăng co bóp mà không làm tụt huyết áp nhiều.

7.6. Độ 4 – hồi sức tích cực

- **Đặt nội khí quản, thở máy.**
- **Chống sốc** (do viêm cơ tim hoặc tổn thương trung tâm vận mạch ở thân não):
  - Không có phù phổi, suy tim: **NaCl 0,9% hoặc Ringer lactat 5 mL/kg/15 phút**, theo dõi sát quá tải.
  - **Dobutamin 5–20 µg/kg/phút.**
- **Phù phổi cấp: ngừng ngay dịch truyền**; dobutamin; **furosemide 1–2 mg/kg TM** khi quá tải dịch.
- Lọc máu liên tục hoặc **ECMO** nếu có điều kiện.
- **IVIG:** chỉ khi **huyết áp trung bình ≥ 50 mmHg**.
- **Kháng sinh:** chỉ khi bội nhiễm hoặc chưa loại trừ nhiễm khuẩn nặng khác.
- Theo dõi **mỗi 30 phút trong 6 giờ đầu**; áp lực tĩnh mạch trung tâm, huyết áp xâm lấn mỗi giờ.

8. TIÊU CHUẨN XUẤT VIỆN

- **Độ 3, 4:** phải ổn định cả **lâm sàng lẫn biến chứng, di chứng**.
- Các trường hợp nội trú khác xuất viện khi **đủ 4 điều kiện**:
  - **Không sốt ít nhất 24 giờ liên tục** (không dùng thuốc hạ sốt).
  - **Không còn biểu hiện từ độ 2a trở lên ít nhất 48 giờ.**
  - Có điều kiện theo dõi tại nhà, tái khám ngay nếu nặng (nếu **chưa đến ngày 8** của bệnh).
  - **Di chứng (nếu có) đã ổn định:** không cần hỗ trợ hô hấp, **ăn được qua đường miệng**.

9. PHÒNG BỆNH

- **Chưa có vaccin** phòng bệnh đặc hiệu; áp dụng biện pháp phòng bệnh **lây qua đường tiêu hóa**, tránh tiếp xúc trực tiếp nguồn lây.
- **Tại cơ sở y tế:**
  - **Cách ly theo nhóm bệnh.**
  - Nhân viên y tế **mang khẩu trang, rửa / sát khuẩn tay trước và sau chăm sóc**.
  - Khử khuẩn bề mặt, giường, buồng bệnh bằng **Cloramin B 2%**, lưu ý **ghế ngồi** ở khu khám.
  - Xử lý chất thải, đồ vải, dụng cụ theo quy trình bệnh lây qua đường tiêu hóa.
- **Tại cộng đồng:**
  - **Rửa tay bằng xà phòng** (nhất là sau thay tã, tiếp xúc phân, nước bọt).

- Rửa sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà; lau sàn bằng **Cloramin B 2%** hoặc dung dịch khử khuẩn khác.
- **Cách ly trẻ bệnh tại nhà**, **không đến trường, nơi tập trung trong 10–14 ngày đầu**.

> **Ghi nhớ cả bài:** TCM do **CA16 và EV71** (EV71 gây nặng), lây **đường tiêu hóa**, gặp nhiều **< 3 tuổi**. Loét **phía sau miệng** + phỏng nước **lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông**. Biến chứng **ngày 2–5**; **giật mình** là dấu hiệu sớm viêm thân não. Phân độ: **1** (chỉ da niêm) → **2a / 2b** (thần kinh) → **3** (mạch > 170, tăng huyết áp, rối loạn thực vật) → **4** (ngừng thở, SpO_2 < 92%, phù phổi, sốc). Không có thuốc đặc hiệu; dùng **phenobarbital, IVIG** theo độ; **không dùng aspirin**; cách ly **10–14 ngày**.

Tài liệu ôn tập biên soạn lại từ Bệnh tay chân miệng.pdf. Phần "Hiểu nhanh", "Vì sao" và liên hệ nha khoa là giải thích bổ sung; đối chiếu tài liệu gốc khi cần chi tiết.